

Số: 841 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 08 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư RIXATHON 500mg/50ml

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc RIXATHON 500mg/50ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là rituximab 10mg/ml, là một kháng thể đơn dòng, gắn đặc hiệu vào kháng nguyên xuyên màng CD20 trên bề mặt tế bào tiền lympho B và lympho B trưởng thành.
- Cơ chế tác dụng: khi rituximab gắn với kháng nguyên CD20 trên các tế bào u lympho B sẽ kích hoạt các phản ứng miễn dịch gián tiếp để tiêu diệt tế bào B theo cơ chế: hoạt hóa bổ thể (CDC), độc tính tế bào phụ thuộc kháng thể (ADCC) và gây cảm ứng sự chết tế bào theo chương trình (apoptosis).
- Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền, không màu đến vàng nhạt.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định		Liều dùng
U lympho không Hodgkin, CD20 dương tính	U nang lympho không Hodgkin hay u tái phát hoặc kháng thuốc mức độ thấp	Liều khuyến dùng 375mg/m ² , truyền tĩnh mạch 1 lần/tuần x 4-8 tuần, có thể thêm một đợt 4 tuần cho người bệnh có đáp ứng với thuốc nhưng khối u vẫn tiến triển. Bệnh nhân có đáp ứng với điều trị khởi đầu có thể duy trì với rituximab 375mg/m ² mỗi 3 tháng cho đến khi bệnh tiến triển hoặc tối đa 2 năm.
	Xạ trị đối với u nang không Hodgkin hoặc u lympho không Hodgkin tái phát hoặc kháng thuốc mức độ thấp	Dùng kết hợp với ibritumomab trong phác đồ miễn dịch-xạ trị: rituximab liều 250mg/m ² truyền trong 4 giờ trước khi dùng ibritumomab
	U nang lympho không Hodgkin chưa được điều trị trước đây	375mg/m ² truyền vào ngày 1 của mỗi chu kỳ hóa trị liệu bằng phác đồ CVP x 8 chu kỳ

	U lympho không Hodgkin độ ác tính thấp, không tiến triển	Phác đồ CVP đã điều trị 6-8 chu kỳ không tiến triển, liều rituximab khuyến dùng là 375mg/m ² truyền tĩnh mạch tuần 1 lần
	U lympho không Hodgkin có tế bào B lớn lan tỏa, chưa được điều trị	375mg/m ² truyền tĩnh mạch vào ngày 1 của mỗi chu kỳ hóa trị liệu dùng phác đồ CHOP, tổng 8 liều
Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho		Rituximab 375mg/m ² truyền tĩnh mạch vào ngày 0 của chu kỳ đầu tiên hóa trị liệu với fludarabin và cyclophosphamid (dùng vào ngày 1-3 của mỗi chu kỳ dài 28 ngày), sau đó truyền 500mg/m ² vào ngày 1 của các chu kỳ tiếp theo x 6 chu kỳ.
Viêm khớp dạng thấp		Dùng glucocorticoid 30 phút trước khi truyền rituximab để giảm thiểu phản ứng nặng do truyền thuốc, mỗi đợt điều trị gồm 2 lần truyền tĩnh mạch cách nhau 2 tuần, mỗi lần 1000mg rituximab
U hạt kèm viêm đa mạch và viêm đa vi mạch		Truyền tĩnh mạch rituximab liều 375mg/m ² tuần 1 lần x 4 tuần

Cách pha: rút một lượng rituximab cần thiết rồi pha loãng bằng dung dịch Natri clorid 0.9% hoặc glucose 5% để thu được dung dịch có nồng độ 1-4mg/ml. Dung dịch sau khi pha loãng được dùng để truyền tĩnh mạch, không dùng để tiêm tĩnh mạch nhanh hoặc truyền nhanh, không được tiêm thuốc chưa pha loãng.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Mẫn cảm với hoạt chất hoặc với protein chuột, bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Nhiễm trùng nặng tiến triển;
- Bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng;
- Suy tim nặng (độ IV theo phân loại của NYHA) hoặc bệnh tim không kiểm soát.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**